インセンティブ制度シミュレーション

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

大橋病院 インセンティブ制度シミュレーション

ー 人事評価連動型 + KPI連動型の二層構造 ー

作成日: 令和8年4月11日
前提: 恒久的なベースアップではなく、単年度のインセンティブ（業績賞与・手当）として設計
設計思想: 基準を高く設定し、頑張っている職員に大きく報いる「メリハリ型」

---

1. 前提条件

1.1 大橋病院の人員構成（推計）

320床の急性期病院（急性期一般入院料1、ICU 6床・HCU 12床・SCU 6床）の標準的な人員構成から推計。

職種	推定人数	平均年収（推定）	備考
医師（常勤）	110名	1,200万円	研修医含む
看護師	350名	530万円	2:1看護体制、ICU/HCU/SCU含む
薬剤師	25名	520万円	
コメディカル（技師・PT/OT等）	80名	470万円	臨床検査、放射線、リハビリ等
事務職員	60名	450万円	医事課、経営企画、総務等
その他（看護補助・栄養士等）	75名	350万円	
合計	約700名	平均約640万円	
人件費総額（推計）	ー	約71億円/年	月次分析レポートの4-2月累計65.2億円を年換算

1.2 財務的制約

制約条件	数値	含意
大橋病院の粗利益	1.2億円/年（利益率0.8%）	インセンティブ原資の上限
経営戦略による増収見込み	+1.6〜4.5億円/年	改善施策が成功した場合のアップサイド
人件費率	41.2%（同クラス平均51.7%）	制度的には引上げ余地あり

中期計画の人件費前提	R8に△5億円（法人全体）	ベースアップとは矛盾するが、インセンティブは変動費

---

2. インセンティブ制度の設計

2.1 二層構造の概要

層	名称	対象	原資の性質	目的
第1層	KPI連動インセンティブ	特定部門・チーム	増収に直結 → 自己回収型	収益向上の直接的動機付け
第2層	人事評価連動インセンティブ	全職員	粗利益からの配分	組織全体の底上げ・人材定着

2.2 第1層：KPI連動インセンティブ（部門別）

特徴: 達成基準を高めに設定し、経営貢献が明確な成果に報いる

KPI項目	対象者	達成基準（高水準）	支給額/回	頻度	年間最大額
ダヴィンチ手術件数	手術チーム（外科・泌尿器・看護・ME）	月15件以上（現状10.2件）	50万円（チーム配分）	月次	600万円
救急入院率	救急科・関連診療科・看護	入院率50%以上（現状45.7%）	30万円（チーム配分）	月次	360万円
紹介件数回復	地域連携室・整形外科	月間紹介件数が前年同月超	20万円（チーム配分）	月次	240万円
算定漏れ防止	医事課・各病棟	施設基準充足率100%維持	30万円（チーム配分）	四半期	120万円
病床稼働率	病棟看護・患者サポートセンター	月間稼働率92%以上（現状88.9%）	30万円（チーム配分）	月次	360万円
第1層 年間合計					最大1,680万円

第1層の自己回収メカニズム:

・ダヴィンチ月15件 ＝ 年180件。現状123件（月10.2×12）からの増加57件 × 手術増収30～50万/件 ＝ +1,710～2,850万円の増収 → 原資600万円を十分カバー

・稼働率92%達成 = 1日平均294人（現状284.5人） → 入院収入+約1億円/年 → 原資360万円を大幅にカバー

2.3 第2層：人事評価連動インセンティブ（全職員対象）

特徴: 全職員が対象だが、評価基準を高く設定し上位者に厚く配分する「メリハリ型」

評価ランクと分布・支給額

評価ランク	基準	想定分布	対象人数	月額換算支給	年間支給額/人

S（卓越）	部門目標を大幅超過し、組織全体に波及効果をもたらした	5%	35名	月額5万円相当	60万円
A（優秀）	部門目標を超過達成し、改善提案を実行に移した	15%	105名	月額2.5万円相当	30万円
B+（良好）	部門目標を達成し、安定した成果を出した	25%	175名	月額1万円相当	12万円
B（標準）	通常業務を遂行	45%	315名	—	0円
C（要改善）	目標未達	10%	70名	—	0円

第2層の年間コスト計算

評価	人数	年間支給額/人	小計
S（卓越）	35名	60万円	2,100万円
A（優秀）	105名	30万円	3,150万円
B+（良好）	175名	12万円	2,100万円
B以下	385名	0円	0円
第2層 年間合計	315名が受給（45%）	—	7,350万円

---

3. シナリオ別シミュレーション

シナリオ1：保守的（増収なし・現状維持の場合）

経営改善施策の効果がまだ出ていない初年度を想定。

項目	金額
大橋病院の粗利益（現状）	1.2億円
第1層 KPIインセンティブ	△1,000万円（部分達成を想定）
第2層 人事評価インセンティブ	△5,000万円（圧縮版）
インセンティブ総額	△6,000万円
インセンティブ後の粗利益	6,000万円
粗利益率	0.4%
人件費増加率	+0.8%

第2層の圧縮版	人数	年間支給額/人	小計
S	35名	40万円	1,400万円
A	105名	20万円	2,100万円
B+	175名	8.5万円	1,500万円
合計	315名	—	5,000万円

評価:

粗利益の半分をインセンティブに充てる形。利益は残るが余裕は少ない。初年度のテスト導入としては妥当。Sランクでも年40万円と「大きく報いる」には物足りない。

シナリオ2：標準（経営改善+1.5億円の増収を達成した場合）

外来患者数の一部回復、ダヴィンチ拡大、算定漏れ防止などが奏功した場合。

項目	金額
大橋病院の粗利益（改善後）	2.7億円（現状1.2億+増収1.5億）
第1層 KPIインセンティブ	△1,500万円（大部分達成）
第2層 人事評価インセンティブ	△7,350万円（フルスペック）
インセンティブ総額	△8,850万円
インセンティブ後の粗利益	1.8億円
粗利益率	1.1%
人件費増加率	+1.2%

評価:
増収の成果を職員に還元しつつ、粗利益1.8億円を確保。Sランクは年60万円（月5万円相当）、Aランクでも年30万円と、頑張った職員に明確に報いる水準。粗利益率も改善前（0.8%）を上回り、経営と人材投資の好循環を実現。

シナリオ3：積極的（経営改善+3億円の増収を達成した場合）

全施策が順調に進捗し、診療報酬改定効果も加わった場合。

項目	金額
大橋病院の粗利益（大幅改善後）	4.2億円（現状1.2億+増収3億）
第1層 KPIインセンティブ	△1,680万円（ほぼ全達成）
第2層 人事評価インセンティブ	△1億500万円（増額版）
インセンティブ総額	△1億2,180万円
インセンティブ後の粗利益	3.0億円
粗利益率	1.9%
人件費増加率	+1.7%

第2層の増額版	人数	年間支給額/人	小計
S	35名	100万円	3,500万円
A	105名	40万円	4,200万円
B+	175名	16万円	2,800万円
合計	315名	—	1億500万円

評価: Sランク年100万円（月8.3万円相当）は「大きく報いる」に値する水準。Aランク年40万円もモチベーションに十分寄与。インセンティブ総額1.2億円は人件費71億円の1.7%であり、同クラス平均（人件費率51.7%）との差10.5ptの中で十分吸収可能。粗利益3.0億円を確保しつつ、人材投資も実現する理想的なシナリオ。

---

4. 三シナリオの比較

指標	シナリオ1（保守）	シナリオ2（標準）	シナリオ3（積極）
前提となる増収	0円	+1.5億円	+3.0億円
インセンティブ総額	6,000万円	8,850万円	1億2,180万円
Sランク年間支給額	40万円	60万円	100万円
Aランク年間支給額	20万円	30万円	40万円
B+ランク年間支給額	8.5万円	12万円	16万円
受給者数（全職員比）	315名（45%）	315名（45%）	315名（45%）
インセンティブ後の粗利益	6,000万円	1.8億円	3.0億円
粗利益率	0.4%	1.1%	1.9%
人件費増加率	+0.8%	+1.2%	+1.7%

---

5. 人事評価基準の設計（高水準設定）

5.1 職種別の評価項目と基準

「頑張っている」を客観的に定義し、基準を高く設定する。

医師

評価項目	B（標準）	A（優秀）	S（卓越）
手術件数	前年同数	前年比+10%以上	前年比+20%以上
新入院患者数	予算達成	予算比+5%以上	予算比+10%以上
紹介件数	前年維持	前年比増加	前年比+15%以上
後進育成	研修医指導実施	学会発表指導+論文投稿	指導した研修医がアワード受賞等
地域連携	紹介元対応	訪問活動月2件以上	セミナー企画・主催

看護師

評価項目	B（標準）	A（優秀）	S（卓越）
重症度・看護必要度の記録精度	基準充足	エラー率0.5%以下	エラー率0%+他者指導

退院支援	計画通り実施	退院調整日数の短縮	在院日数短縮に病棟レベルで貢献
インシデント・アクシデント	報告遵守	予防的取組み提案	部署横断的な改善活動リード
業務改善	通常業務遂行	改善提案1件以上/半期	提案が院内採用され効果実証
後輩育成	プリセプター遂行	新人の離職率0%	教育プログラム企画・実施

コメディカル・事務職

評価項目	B（標準）	A（優秀）	S（卓越）
業務目標達成	目標達成	目標超過（110%以上）	目標超過+業務範囲の拡大
算定・請求精度（医事課）	エラー率基準内	エラー率50%削減	算定漏れ発見+増収提案
効率化・DX推進	既存業務遂行	業務効率化提案1件以上	DXツール導入・定着に主導的役割
チーム貢献	チーム内協力	部署横断的な活動参加	委員会・プロジェクトの主導

5.2 Sランクの基準イメージ

Sランクは「自分の仕事を超えて、組織全体に価値をもたらした人」にのみ付与。

具体例：
- 整形外科の医師が紹介元への訪問活動を月5件以上行い、紹介件数を前年比+20%回復させた
- 病棟看護師長が退院支援フローを再設計し、病棟の平均在院日数を0.5日短縮させた
- 医事課スタッフが施設基準管理システムの運用を主導し、算定漏れゼロを達成した
- 臨床工学技士がダヴィンチ新術式のトレーニングプログラムを設計し、スムーズな導入を実現した

---

6. 導入ロードマップ

時期	アクション	備考
R8 Q1（4月）	制度設計の確定・就業規則の改定	第1層KPIインセンティブを先行導入
R8 Q2（7月）	人事評価基準の策定・管理職への研修	評価者トレーニングが鍵
R8 Q3（10月）	中間評価の実施・フィードバック	上期KPIの達成度を確認し原資を見積り
R8 Q4（1-3月）	年度末評価・インセンティブ支給	粗利益確定後に第2層の支給額を最終決定
R9 Q1（4月）	制度の検証・改善	初年度の運用結果を踏まえて基準を調整

---

7. リスクと対策

リスク	影響	対策

増収が計画を下回り原資不足	インセンティブ額の縮小 → 職員の失望	粗利益連動型にすることで、原資が自動調整される設計とする
評価の公平性への不信	モチベーション低下	評価基準の事前公開、評価者研修、異議申立て制度
Sランクの乱発	原資超過、制度の形骸化	Sランクは院長承認制（部門長推薦→院長決裁）とし、上限5%を厳守
部門間の不公平感	特定部門にインセンティブが偏る	第1層（部門KPI）と第2層（全職員評価）の二層構造で全員にチャンスを保証
人件費増が法人の中期計画と矛盾	法人からの指摘	インセンティブは変動費であり、増収に連動して支給 → 増収なければ支給なし、と説明

---

8. 推奨：シナリオ2（標準）での段階的導入

理由:

Sランク年60万円、Aランク年30万円は「頑張りに大きく報いる」水準として説得力がある
インセンティブ総額8,850万円は、+1.5億円の増収に対する還元率59%であり、職員と経営の適切なバランス
粗利益1.8億円（率1.1%）を確保でき、法人への貢献も維持
初年度はシナリオ1（保守）で導入し、増収が確認されたらシナリオ2に移行する段階的アプローチが最も安全
粗利益連動型とすることで、収益が上がれば自動的にインセンティブも増える好循環を構築

出典

略称	正式名称
月次分析レポート	大橋病院 2025年度2月実績 経営分析レポート
事業活動収支予算書	令和7年度事業活動収支予算書.pdf
法人全体収支計画	法人全体収支計画_新中期経営計画(令和7年度~令和9年度).pdf
貸借対照表	令和6年度貸借対照表.pdf
上期事業運営状況	令和7年度上期の事業運営状況について.pdf
組織目標 各所属	組織目標（年度運営方針）令和8年度 各所属.pdf